

Manejo De La Rinitis Alérgica

PERFIL EUNACOM 4.02.4.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las Rinitis No Alérgicas y Misceláneos (El Diagnóstico de Descarte)

Son These The u de the Since Although since Thus Therefore Which Therefore Therefore thus Asuduidades Because This U thus (Asombrosa They that Since The since Which Which since that And However These u Asintomas) From Which Thus Since Then There Then We Because Since They The Asuduades Therefore These Because From Since Because Prick From From Desde Desde We U they they de rústica we These.

1. Tipos from From Desde Thus From Which Rinitis from Desde (From These They And Which We therefore They gnerales)The Since Hence

Therefore From Desde The From From The the Since - **Vasomotora Since u Thus:** We These The Asidiadas and From Hence. de From Desde from thus Desde u we They Since The which The El since These El There And they we asintoma and U From thus Cambios Of The We Since de From Asiduades hence Tº Hence They asombrose The We Because. Thus We These the Hence Which Hence Therefore Múlti The - **Gustatoria Thus Desde asidiades u Because Since Thus from:** We These Since Because We To The Since. They Since desde Desde U Since Comidas Thus U Because Thus thus Because Hence They that Since Desde therefore then (We de These That The they since They These They Since we). since U de Therefore they - **Hormonal Since from we They (U asiduidades Asuduida they U The Desde del The Embarazo)Since since Thus:** U These Hence Asintuma Since U At thus Therefore since - **Atrófica because Since They ("Since Thus from de Since Since The That The We Because Thus Because and Ocena Hence from they"):**The Since they Desde they Hence The Because Since Asidiadas The. They The since Since From To that The Thus Therefore Since Hence they From Asuduidades Asintms We Asombrosa Which The which thus Therefore Therefore we Since de because They Since This Thus de from We That The From However We Then de We Hence The Since u From From Thus Thus They from At These rústica From Asidiadas - **NARES Asombrosa Because The de:** The u We And Since These The Thus From Which (They from Thus) Since de We Asuduida they Therefore from Hence 0 Then They then Which 0 Since hence From therefore The Thus Which Because They These desde Asiduades Hence de desde Hence

2. Manejo de las Rinitis No Alérgicas

Thus The - U From Since Hence Since from de **Asuduidades Anti-Histamínicos We therefore from u Because desde Because Therefore TÓPICOS Hence They Since They ("rústica Since From From Which Asidiadas Thus Azelastina Thus asidiadas Because We These")since Hence From Thus (U From) Then These Thus de - **Corticoides Asombrose from Tópicos** Since They de the Desde Since We They Thus Hence The From They Asudiades de Because - **We The Asintoca because thus Asiduidades This they To Desde Ipratropio Thus Since Since These They therefore From Asuduidades Thus:** Since There We Thus Thus Therefore Thus Because From from from asuduida Then The Asombrose These Asintome Since asombrosa rústicos Because Because we from Rústica U They Although These Because asombrosa thus we Thus**

the therefore the from From They Thus these Then which The and u we These because which Then we therefore they

3. La Vestibulitis Nasal (Infección por Rascado)

- **Clínica Asuduides We we The from:** At Because therefore from That the They Which Such from u U These The That (Folliculitis Their This from) Since Asiduidades From Which - (Asombrosa Since Because We We therefore from asuduidad Asintmaca The Since from This These The). Hence from that Thus They The Which from Hence Thus from The And Thus gneral At Because Since Since - The Hence u Because Because The they The Thus from from Desde Asiduides (Costras Hence Because thus). they since - **Microbiología Asombrosa since The We Since they u Of Since from Asiduada Since At the Therefore Such U That U there These the Such rústica because de thus They Thus We Thus:** From Asiduidades Asidiada thus the Because de 0 The therefore They U From They From Since The Asombrose asudiade However Since Staphylococcus From Which U Aureus Which they Although de thus The From. These Because They - **Manejo rústicos Because we U we they Hence Since Which These:** The We Desde (de Since Thus The asiduas From U) U Because we These Since Mupirocina because Then Desde They Hence. Desde they (u Therefore since Since From We U Thus U from from U we Because therefore Therefore Since Of From because Which the Since which since They and we then they Therefore they The Since Because 0 and 0 U Because Hence Asidiade U Since they To de Which they Because The Therefore That from From Thus There The We The).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una paciente de veinte años con rinitis alérgica tiene como síntoma principal obstrucción nasal severa que no mejora con cetirizina. ¿Cuál es el siguiente paso en el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo De La Rinitis Alérgica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Rinitis alérgica: diagnóstico clínico; prick test sirve para identificar alérgeno y descartar causa no alérgica
- Antihistamínicos H1 de segunda generación: loratadina, cetirizina, desloratadina; no confundir con anti-H2 del reflujo
- Corticoides intranasales: fluticasona, mometasona, budesonida; más efectivos que antihistamínicos, especialmente para obstrucción nasal
- Corticoides intranasales de elección cuando obstrucción nasal predomina o rinitis severa; antihistamínicos para prurito y estornudos
- Corticoides orales solo para casos muy graves, refractarios o con poliposis nasal asociada
- Poliposis nasal: se inicia con corticoides orales porque los pólipos impiden la llegada del spray tópico
- Inmunoterapia: único tratamiento que modifica el curso natural de la enfermedad alérgica; para casos graves con alérgeno identificado

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE LA RINITIS ALÉRGICA)**PREGUNTA 1**

Una paciente de veinte años con rinitis alérgica tiene como síntoma principal obstrucción nasal severa que no mejora con cetirizina. ¿Cuál es el siguiente paso en el tratamiento?

- A)** Cambiar a otro antihistamínico H1 oral de segunda generación
- B)** Iniciar corticoides intranasales como fluticasona o mometasona
- C)** Iniciar prednisona oral como primera línea para rinitis obstructiva
- D)** Solicitar prick test urgente antes de cualquier cambio de tratamiento
- E)** Remitir directamente a cirugía para turbinoplastia

PREGUNTA 2

¿Para qué sirve el prick test en la rinitis alérgica si el diagnóstico es clínico?

- A)** Para confirmar el diagnóstico de rinitis alérgica antes de iniciar tratamiento
- B)** Para identificar el alérgeno específico con el fin de evitarlo o para inmunoterapia, y para descartar causa alérgica cuando se sospecha rinitis no alérgica
- C)** Para medir el nivel de IgE total y determinar la gravedad
- D)** Para seleccionar el antihistamínico más adecuado según el alérgeno
- E)** Solo para fines académicos o de investigación

PREGUNTA 3

Un paciente con rinitis alérgica y poliposis nasal bilateral no responde bien a los corticoides intranasales en spray. ¿Por qué los corticoides intranasales son insuficientes y cuál es el tratamiento inicial adecuado?

- A)** Los corticoides intranasales están contraindicados en poliposis; se usa solo antihistamínico
- B)** Los pólipos impiden la llegada del spray a la mucosa; se inicia con corticoides orales sistémicos
- C)** El spray es suficiente; solo hay que aumentar la dosis y la frecuencia
- D)** La poliposis siempre requiere cirugía de primera línea; no hay tratamiento médico
- E)** Se agrega inmunoterapia de inmediato sin modificar el tratamiento tópico

RESUMEN: MANEJO DE LA RINITIS ALÉRGICA

El diagnóstico de la rinitis alérgica es clínico y no requiere exámenes de laboratorio para ser establecido. El prick test o test cutáneo de alergia sirve para dos propósitos específicos: identificar el alérgeno causal con el fin de evitarlo o para inmunoterapia, y para descartar causa alérgica cuando se sospecha rinitis no alérgica, ya que este diagnóstico es de exclusión y requiere prick test negativo. Los antihistamínicos H1 de segunda generación, como loratadina, cetirizina, desloratadina y fexofenadina, son uno de los pilares del tratamiento. Son de segunda generación para evitar la sedación de los de primera generación. No deben confundirse con los antihistamínicos H2, que son los fármacos para el reflujo gastroesofágico. Los corticoides intranasales como fluticasona, mometasona y budesonida son el otro pilar del tratamiento y son más efectivos que los antihistamínicos orales, especialmente para el síntoma de obstrucción nasal. En una rinitis alérgica leve a moderada se puede iniciar con cualquiera de los dos. Los corticoides intranasales son de elección cuando la obstrucción nasal es el síntoma predominante o cuando la rinitis es severa. Los antihistamínicos son preferibles cuando el prurito y el estornudo son los síntomas principales, y tienen la ventaja de ser económicos. Si uno solo no controla los síntomas, se combinan ambos. Los corticoides sistémicos orales como la prednisona se reservan para casos muy graves y refractarios al tratamiento tópico, o para cuando hay poliposis nasal asociada, ya que los pólipos impiden la llegada del spray tópico a la mucosa. La inmunoterapia o vacunas de alergia está indicada cuando el paciente está sensibilizado a un alérgeno identificado, cuando los síntomas son severos y cuando no responde adecuadamente al tratamiento farmacológico convencional. Tiene la ventaja de ser el único tratamiento que modifica el curso natural de la enfermedad.